

Život s diabetom a nefropatiou

V pokročilých štádiách a na dialýze: praktický edukačný sprievodca

MUDr. Ľubomír Polaščín

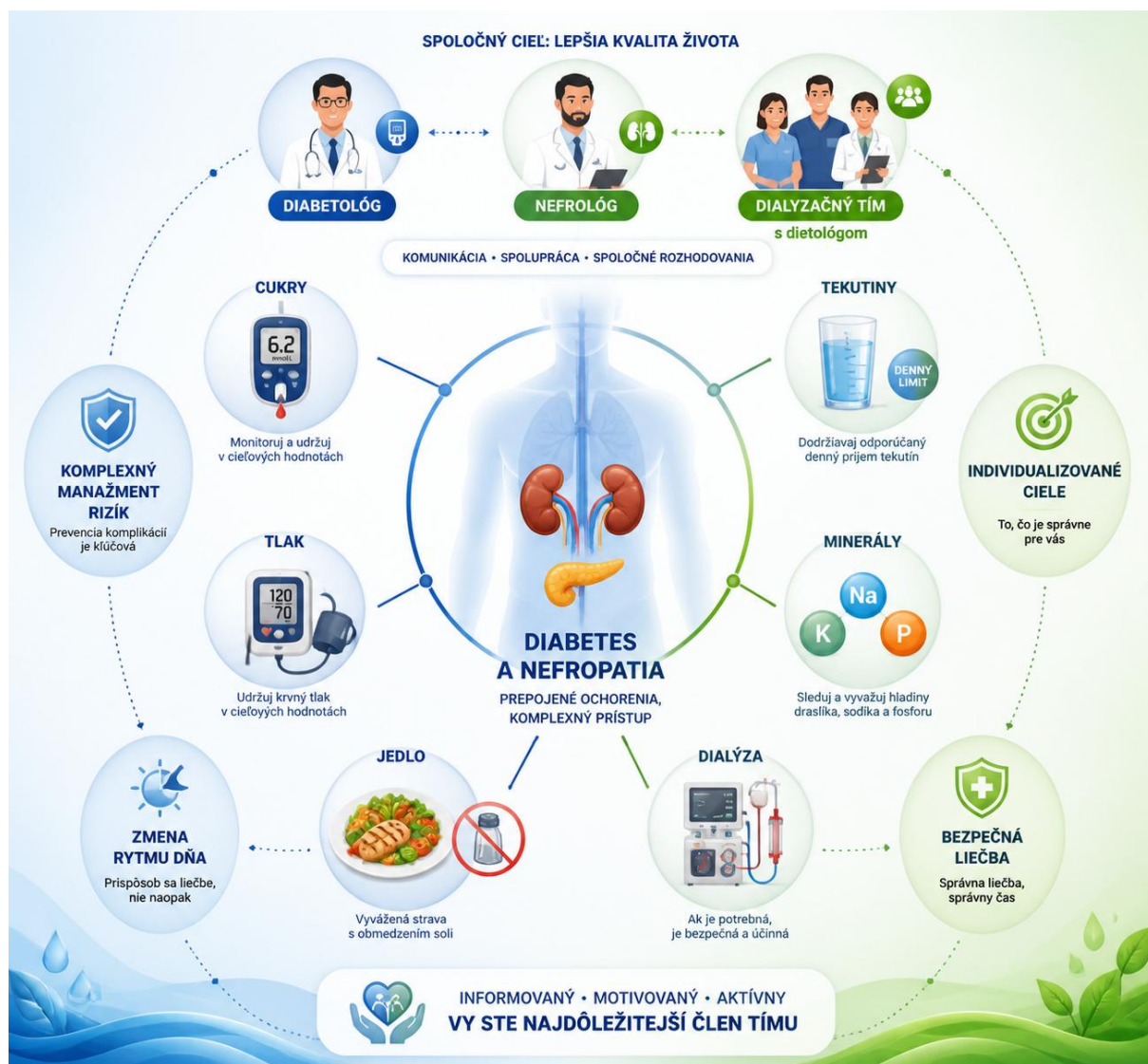
Nefrológ a internista



Keď sa k diabetu pridá nefropatia, človek si často uvedomí, že „liečba diabetu“ už nie je samostatná téma. Zrazu ide o jeden spoločný príbeh, kde sa spájajú cukry, tlak, tekutiny, minerály v krvi a aj to, ako vaše telo reaguje na jedlo a samotnú dialýzu. Preto odporúčania pre diabetes pri chronickom ochorení obličiek (CKD) zdôrazňujú, že ide o **komplexný manažment rizík** a že ciele sa musia prispôbiť štádiu ochorenia a vášmu konkrétnemu profilu rizík [1,2].

V pokročilých štádiách nefropatie (pred dialýzou) a najmä na dialýze sa potom mení rytmus dňa, mení sa aj to, čo je „správne“ v jedle a pití. Nejde však o náhodné obmedzovanie. Je to snaha udržať stabilitu vnútorného prostredia tak, aby ste mali menšie výkyvy, menej komplikácií a aby liečba diabetu aj obličiek bola bezpečná.

V tomto článku ukážem, ako na to v praxi – od stravy cez pitný režim až po význam komunikácie medzi diabetológom, nefrológom a dialyzačným tímom (a často aj dietológom), aby ste dosiahli bezpečnú starostlivosť



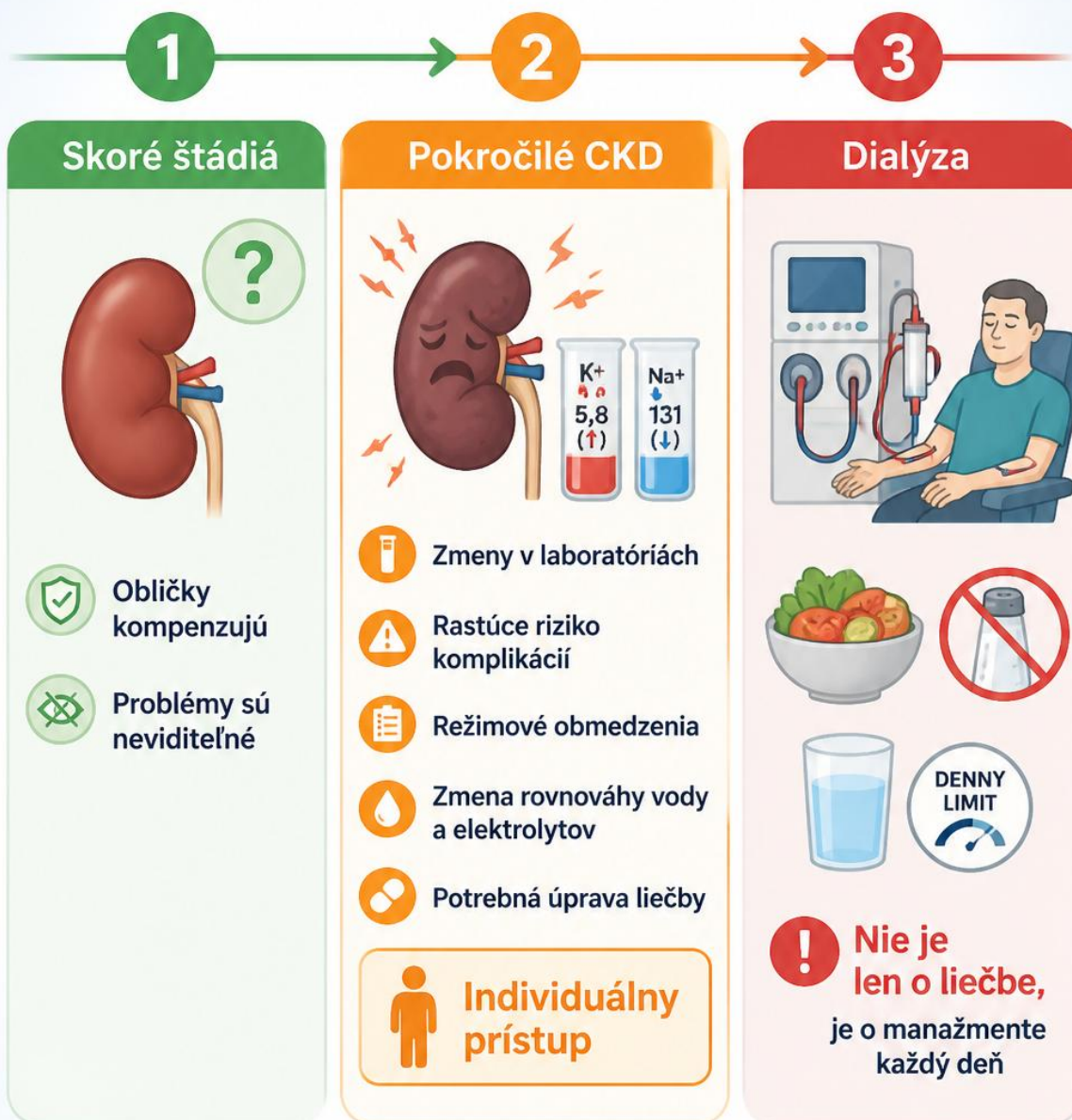
Prečo sa v pokročilom štádiu menia „pravidlá hry“ (a prečo sa to nedá mať rovnako pre všetkých)

V skorších štádiách môže človek s diabetom dlho žiť „bez toho, aby boli obličky viditeľné“. Obličky totiž spoiatku fungujú kompenzačne. Až neskôr sa začne odzrkadľovať to, čo sa dialo v pozadí: objavujú sa zmeny v laboratóriách, rastie riziko komplikácií a postupne sa pridávajú aj režimové obmedzenia. Včasná diagnostika a starostlivosť môžu výrazne zlepšiť vaše vyhliadky.

Pri pokročilom CKD sa mení schopnosť obličiek udržiavať rovnováhu vody a elektrolytov a lieky sa musia prispôbiť. KDIGO zdôrazňuje, že cieľom je vyvážiť prínos liečby a riziká, pričom každý pacient vyžaduje individuálny prístup, čo znamená úpravy liečby pri zmene režimu, stravy alebo začatí dialýzy

A potom je tu ešte dialýza. Dialýza nie je „magický reset“. Je to liečba s presnými pravidlami, ktorá má svoje limity a riziká (napríklad preťaženie tekutinami alebo elektrolytové zmeny počas sedenia). Preto sa aj výživa a pitný režim na dialýze nastavujú tak, aby sa dialýza dala bezpečne a opakovane zvládnuť.

Prečo sa menia “pravidlá hry” pri pokročilej nefropatii?



Čím pokročilejšie ochorenie,
tým komplexnejší prístup a väčšia zodpovednosť.

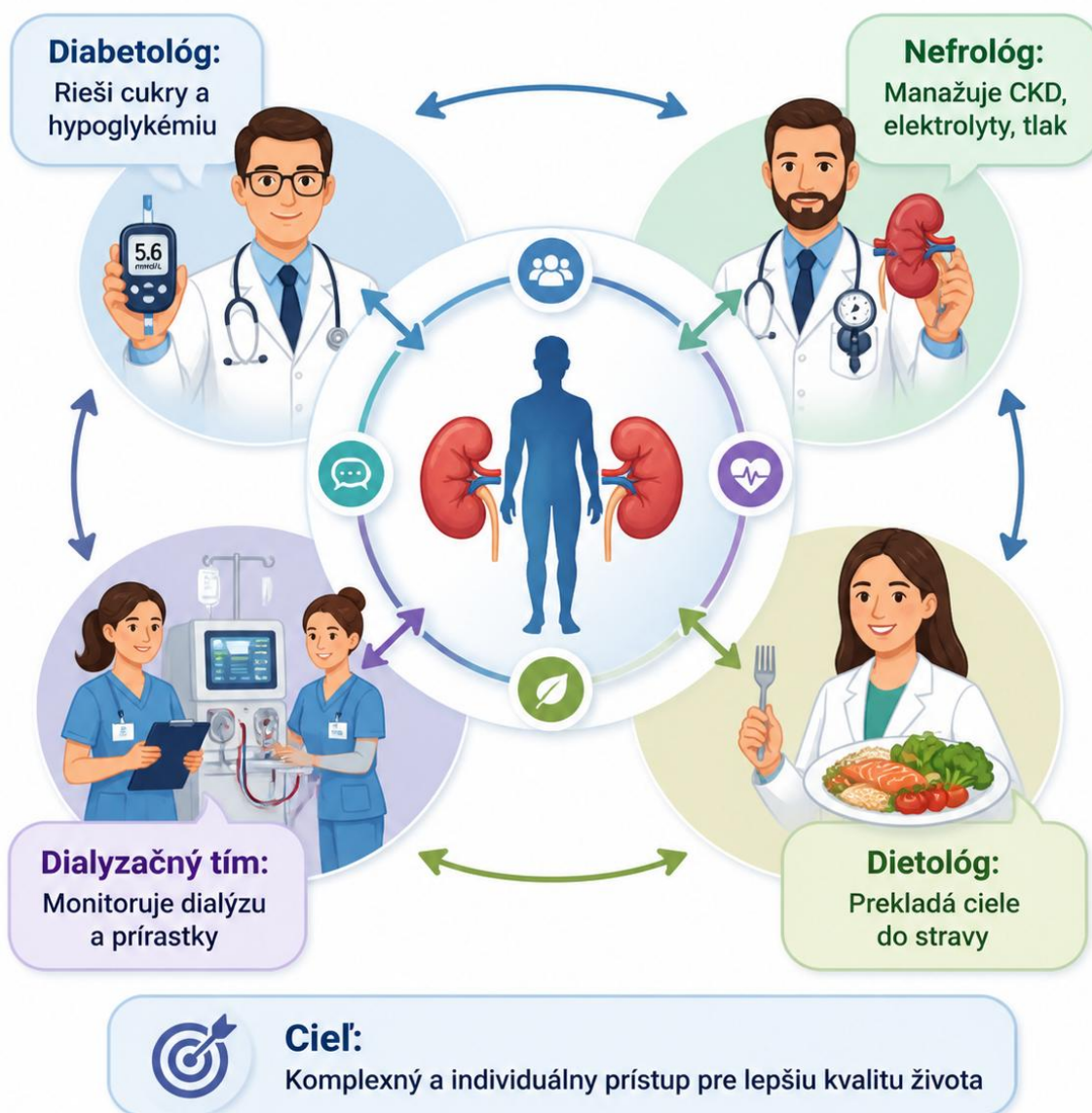
Spolupráca špecialistov: prečo je „tím“ dôležitejší než jedna správna rada

Mnohí pacienti sa cítia rozpoltení: každý špecialista im povie niečo správne – ale v inom kontexte. To je normálne, lebo každý rieši inú časť problému.

Diabetológ zvyčajne rieši bezpečné nastavenie cukrov (a v pokročilom štádiu aj riziko hypoglykémie). Nefrológ rieši CKD/diurézu, elektrolyty, tlak, progresiu ochorenia a načasovanie dialýzy (alebo režim pred dialýzou). Dialyzačný tím vie najlepšie, ako vyzerá váš „reálny“ dialyzačný priebeh: ako znášate sedenie, aké máte typické ťažkosti a aké bývajú vaše prírastky medzi dialýzami. Dietológ potom tieto medicínske ciele preloží do stravy tak, aby bola praktická a zároveň bezpečná.

Tento prístup – prepojenie edukácie, monitorovania a tímovej starostlivosti – zodpovedá tomu, ako sa odporúčania opakovane formulujú: nie „jedna rada pre všetkých“, ale plánovanie podľa rizík a podľa výsledkov v čase [1,2,4]. Vaša aktívna účasť a porozumenie sú kľúčové pre úspešnú liečbu a lepšiu kvalitu života.

Tímová spolupráca: Prečo je "tím" dôležitejší než jedna rada



Strava: prečo pri nefropatii nejde len o to „čo nejest“, ale aj o to, čo si organizmus nevie dovoliť

Pri pokročilej nefropatii sa často hovorí o obmedzení príjmu draslíka, fosforu a sodíka. To je pravda, ale dôvod je ešte hlbší: ide o to, že obličky (alebo dialýza) nezvládajú tieto látky v rovnakom rozsahu ako zdravé obličky.

Strava a nefropatia:
Prečo nejde len o to, čo nejesť.

Draslík	Fosfor	Sodík
! Obmedzená schopnosť obličiek spracovať	! Obmedzená schopnosť obličiek spracovať	! Obmedzená schopnosť obličiek spracovať

Zdravé obličky, lepší život.

Vyvážená strava Dostatok tekutín (ak je povolené) Pravidelný pohyb Kontrola zdravia

Soľ (sodík) a tlak: prečo strava ovplyvňuje pitný režim viac, než si človek myslí

Keď je v strave veľa sodíka, zvyčajne sa zvýši smäd a zároveň sa zvyšuje riziko, že medzi dialýzami (alebo aj v predialyzačnom období) bude v tele viac tekutín. To následne znamená väčší prírastok hmotnosti, vyšší tlak a horšiu toleranciu dialýzy.

Práve preto dialyzačné edukácie kladú dôraz na to, aby pacient rozumel tomu, že pitný režim sa nedá udržať bez úpravy stravy a najmä bez obmedzenia soli [5,6,7]. Prakticky to býva najväčší rozdiel v tom, či režim „ide“ alebo či je človek neustále v smäde a pod tlakom.



Draslík: prečo sa nevyberá podľa zoznamu z internetu

V CKD a na dialýze môže draslík v krvi rásť. Príliš vysoký draslík môže byť nebezpečný pre srdce, a preto sa s ním opatrne pracuje. Ale obmedzenia draslíka nie sú pre každého identické: závisia od vašich aktuálnych hladín, od dialyzačnej schémy a často aj od toho, čo sa vám v praxi reálne darí jesť.

Preto sa v edukáciách opakovane zdôrazňuje individualizácia a sledovanie laboratórií. Dietoterapia v nefropatii je „vedená cieľmi“ – laboratórne hodnoty určujú, čo je v danom čase problém [1,4,7].



Draslík a nefropatia:

Prečo zoznamy z internetu nestačia



1 Riziko vysokého draslíka



V CKD a na dialýze
môže draslík rásť.
Vysoký draslík je
nebezpečný pre srdce.



2 Individualizácia je kľúčová



1. Vaše laboratóriá



2. Dialyzačná schéma



3. Čo reálne jete

Obmedzenia draslíka závisia od vašich aktuálnych hladín,
dialyzačnej schémy a vašej stravy.

3 Dietoterapia vedená cieľmi

Laboratórne hodnoty určujú,
čo je aktuálne problém.

LABORÁTORNE VÝSLEDKY	
	Hodnota
Draslík (K+)	5,6 mmol/l
Kreatinin	450 µmol/l
Urea	18,2 mmol/l
Fosfor	1,6 mmol/l



Konzultujte vždy s lekárom a dietológom.
Nikdy si nevyberajte stravu podľa neoverených zdrojov.



Fosfor: prečo sa rieši dlhodobo, aj keď sa človek necíti „chorý“

Fosfor pri CKD často narastá postupne a dlhodobo to môže poškodzovať kosti a zvyšovať riziká spojené s minerálovým metabolizmom. Preto sa strava prispôsobí a ak máte predpísané viazače fosforu, sú súčasťou stratégie, nie „doplnkom k režimu“.

Pritom je veľmi dôležité načasovanie viazačov. V praxi sa veľa problémov stane z drobností – napríklad z toho, že tabletky nie sú užívané presne s jedlom alebo sa vynechajú v dňoch, keď má pacient horšiu chuť do jedla. Dialyzačné a renálne nutričné materiály preto fosfor uvádzajú ako jednu z centrálnych tém stravy [4,6,7].

Fosfor a nefropatia: Prečo sa rieši dlhodobo?

1 Prečo je fosfor problém?



ZDRAVÁ
OBLIČKA



OBLIČKA PRI
CKD



Fosfor pri CKD narastá postupne a môže poškodzovať kosti a zvyšovať riziká minerálového metabolizmu.



OSLABENIE KOSTÍ



ZVÝŠENÉ RIZIKO
KARDIOVASKULÁRNYCH
OCHORENÍ

2 Riešenie a dôležitosť

2.1 Úprava stravy



Strava sa prispôsobí.

2.2 Vázce fosforu



Vázce fosforu sú súčasťou stratégie, nie doplnkom.



Kľúčové je načasovanie väzcov – presne s jedlom.

2.3 Dôsledky nesprávneho užívania



Problémy z nesprávneho užívania (nie s jedlom, vynechané).

3 Záver



Fosfor je centrálnou témou stravy pri nefropatii.

Dlhodobé riešenie = lepšie zdravie, menej komplikácií, lepší život.



Riešme fosfor dlhodobo každý deň.



Strava + väzce + načasovanie = úspech.



Chráňme kosti, srdce a cievy.



Vaše zdravie je na prvom mieste.

Bielkoviny a energia: prečo na dialýze môže byť problém skôr opačný než „jesť menej“

Ľudia s ochorením obličiek niekedy znížia príjem bielkovín zo strachu. Lenže dialýza a pokročilé CKD zvyšujú riziko podvýživy a svalového úbytku. Preto nutričné odporúčania pri CKD a najmä pri dialýze pracujú s tým, aby pacient nebol v energetickom deficite a aby mal dostatok bielkovín v dávkovaní podľa štádia a stavu [4,6].

Je dôležité povedať jednu vec „ľudsky“: cieľom nie je hladovať. Je cieľom jesť tak, aby boli všetky relevantné parametre (sodík, draslík, fosfor, energia, bielkoviny) v rovnováhe. A to sa robí s dietológom a podľa vašich výsledkov.



Bielkoviny a energia pri ochorení obličiek:

Prečo „jesť menej“ nemusí byť vždy správne



1 Riziko podvýživy a svalového úbytku

 Pacienti s ochorením obličiek často znižujú príjem bielkovín zo strachu.

 Dialýza a pokročilé CKD zvyšujú riziko podvýživy a svalového úbytku.



2 Nutričné odporúčania: Rovnováha je kľúčová

 **Cieľ:** Energetický dostatok a primeraný príjem bielkovín.

 Nie je cieľom hladovať, ale jesť tak, aby boli všetky parametre v rovnováhe (sodík, draslík, fosfor, energia, bielkoviny).

 ENERGIA



 BIELKOVINY

 SODÍK

 DRASLÍK

 FOSFOR



3 Individualizovaný prístup

 Pracujte s dietológom.

 Riadte sa vašimi výsledkami (labáky).



VÝSLEDKY

UREAZIN	✓
DRASLÍK	✓
FOSFOR	✓
SODÍK	✓
BIELKOVINY	✓
ALBUMÍN	✓



Vaše zdravie je komplexné, vaša strava tiež.
Nerobte rozhodnutia sami.

 INDIVIDUALITA

 INFORMÁCIE

 SPOLUPRÁCA

 LEPŠIA KVALITA ŽIVOTA

Pitný režim: prečo je to jedna z najťažších častí dialýzy a zároveň najviac „naučiteľná“

Pitný režim sa často vníma ako disciplína. Ale správne nastavený pitný režim je najmä o fyziológii a plánovaní. Dialýza odstraňuje tekutiny v určitom čase a do určitej miery. Ak medzi dialýzami vypijete viac, telo sa postupne preplní tekutinami a dialýza musí uberať viac – čo zvyšuje riziko poklesu tlaku, kŕčov, dýchavičnosti a nepohody počas sedenia.

Preto americká National Kidney Foundation aj mnohé dialyzačné edukačné materiály zdôrazňujú, že tekutinové obmedzenie má byť presne podľa predpisu vášho tímu a že pomáha pracovať so stratégiami (sledovanie príjmu, náhrady pri smäde a najmä zníženie príjmu sodíka, aby smäd rástol menej) [5]. Slovenské dialyzačné príručky pre pacientov túto logiku rozvádzajú tak, že pitný režim a prírastky medzi dialýzami sú kľúčové pre komfort a bezpečnosť dialýzy [6].

Je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, že tekutinový limit nie je „trest za nedisciplinovanosť“. Limit sa dá diskutovať. Ak sa vám nedarí držať limit, často to nie je len o pití, ale aj o soli v jedle, o tom, ako máte nastavené dávky liekov (napr. na tlak alebo režimy súvisiace s diabetom) a o tom, či máte správne zvládnutú hydratáciu pri horších dňoch.



Pitný režim pri dialýze: Výzva, ktorá sa dá zvládnuť



1 Prečo je pitný režim taký dôležitý?



Obličky zdravého človeka odstraňujú tekutiny priebežne.



Dialýza odstraňuje tekutiny v určitom čase.



Nadmerný príjem vedie k preťaženiu tela.

2 Následky nadmerného príjmu tekutín



Väčší prírastok hmotnosti

Nadbytočná tekutina sa prejaví zvýšením hmotnosti medzi dialýzami.



Vyšší tlak

Preťaženie tekutinou zvyšuje krvný tlak a zafarňuje srdce a cievy.



Dýchavičnosť

Tekutina sa môže hromadiť v pľúcach a spôsobovať ťažkosti s dýchaním.



Krče

Nerovnováha tekutín a elektrolytov môže viesť k bolestivým kŕčom.



Nepohoda počas dialýzy

Môže sa prejavíť nevoľnosťou, nízkym tlakom, bolesťou hlavy či únavou.

3 Stratégie pre zvládnutie pitného režimu



Dodržiavajte predpis tímu

Váš dialyzačný tím pozná vaše potreby. Dodržiavajte odporúčaný denný limit tekutín.



Sledujte príjem tekutín (napr. denník)

Zapíšte si, čo a koľko pijete. Pomôže vám to lepšie vnímať svoj príjem a zostať v limite.



Náhrady pri smáde (citrón, kocky ľadu)

Citrón, cucanie ľadu či žuvačky bez cukru môžu pomôcť zmierniť pocit smádu.



Znížte príjem sodíka (menej soli v strave)

Menej soli = menej smádu = ľahšie dodržiavanie limitu tekutín.



Individualizovaný prístup je kľúčový.

4 Kľúčové posolstvo

Limit nie je trest, ale nástroj pre komfort a bezpečnosť.

Ak máte problémy, hľadajte príčiny (soľ, lieky, hydratácia).



Spolupráca s tímom



Lepší komfort



Bezpečnosť



Kvalitnejší život



Spoločne to zvládneme! ❤️

Diabetes pri nefropatii a na dialýze: prečo sa mení riziko hypo/hyperglykémie a prečo nesmiete improvizovať

V pokročilom CKD sa mení „správanie“ organizmu. Zmení sa tolerancia jedla, zmení sa aj rytmus dialýzy, často sa mení aj chuť do jedla (alebo sa mení typ jedál podľa draslíka/fosforu). To u určitých ľudí mení priebeh glykémie počas dňa.

K tomu sa pridáva aj to, že pri CKD a dialýze môžu byť niektoré lieky pre organizmus „z hľadiska bezpečnosti“ iné. KDIGO preto odporúča individualizovať liečbu diabetu aj ciele a zdôrazňuje, že pri CKD treba zohľadniť riziká vrátane hypoglykémie [1,2]. V praxi to znamená, že keď nastane zmena režimu (napríklad deň pred dialýzou, deň po dialýze, menej jedla, zmenený príjem tekutín), dávkovanie liekov by sa nemalo riešiť „od oka“.

Ak sa vám pri dialýze opakovane robí zle (napríklad tras, potenie, zmätenosť, slabosť, výrazne nízke hodnoty), nepovažujte to za „osobnú slabosť“. Je to signál, že plán treba prekalibrovať v spolupráci s diabetológom a dialyzačným tímom [1,6].

Diabetes pri nefropatii a dialýze: Prečo je dôležitá opatrnosť?

1 ZMENY V ORGANIZME

Menia sa faktory ovplyvňujúce glykémiu.



Zmenená tolerancia potravy



Zmenený rytmus dialýzy



Zmenená chuť do jedla a apetít

2 RIZIKÁ A LIEKY



Niektoré lieky majú pri CKD a dialýze zmenený bezpečnostný profil.



↑ HYPER-GLYKÉMIA
↓ HYPO-GLYKÉMIA

Zvýšené riziko hypo/hyperglykémie.

3 INDIVIDUALIZÁCIA LIEČBY



KDIGO odporúča individualizovať liečbu a ciele diabetu.



Neimprovizujte! Dávkovanie liekov podľa tímu.

4 SIGNÁLY A SPOLUPRÁCA



tras potenie slabosť

Príznaky ako tras, potenie, slabosť nie sú slabosťou, ale signálom.



NEFROLÓG DIABETOLOG DIETETIK /SESTRA

Je potrebné prekalibrovať plán v spolupráci s lekármi.

Každý pacient je jedinečný. Bezpečnosť, flexibilita a spolupráca sú kľúčom k úspechu.

Viazače fosforu, doplnky a lieky: najčastejšie chyby sú v drobnostiach

V praxi býva problém v tom, že si pacient niekedy myslí, že „vitamín“ alebo „doplnok minerálov“ je automaticky bezpečný. Pri CKD to však nie je pravda. Draslík a fosfor sa môžu zhoršovať aj prostredníctvom doplnkov, nie iba cez jedlo. A niektoré doplnky môžu zasahovať do rovnováhy alebo do toho, ako sa cítite počas dialýzy.

Rovnako viazače fosforu fungujú len vtedy, ak sú použité správne. Preto sa v edukáciách opakovane zdôrazňuje, že lieky pri obličkových komplikáciách nie sú „voliteľné podľa chuti“, ale sú súčasťou liečebnej stratégie [4,6,7].

Toto je miesto, kde sa oplatí spraviť jednu jednoduchú vec: mať zoznam liekov a dávok a vždy ho ukázať pri kontrole diabetológa aj nefrológa (a najmä dialyzačnému tímu). To znižuje riziko, že sa niečo prehliadne.



Viazače fosforu, doplnky a lieky: Chyby v drobnostiach



1

Doplnky a ich riziká

Riziko pre obličky



Pacienti si niekedy myslia, že doplnky sú automaticky bezpečné.



Pri CKD však môžu zhoršovať draslík a fosfor.

2

Viazače fosforu - kľúč k úspechu

Správne užívanie



Viazače fosforu fungujú len vtedy, ak sú správne načasované s jedlom.

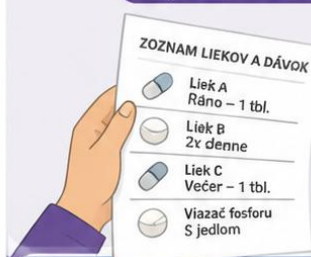


Sú súčasťou liečebnej stratégie, nie sú voliteľné.

3

Kľúčová rada: otvorená komunikácia

Majte zoznam liekov



Ukážte zoznam liekov a dávok vždy nefrológovi, diabetológovi a dialyzačnému tímu.



Znižuje to riziko prehliadnutia.



Vaše zdravie je komplexné. Otvorená komunikácia a presnosť sú kľúčom k bezpečnosti a účinnej liečbe.



Pred dialýzou vs. na dialýze: prečo sa pravidlá môžu líšiť aj v tom, na čo najviac „dávate pozor“

V predialyzačnom období CKD je cieľom často spomaliť progresiu a zachovať stabilitu. Tam môže byť tekutinový režim menej „ostro ohraničený“ ako na dialýze, no aj tak často sú potrebné úpravy podľa príznakov, tlaku a laboratórií.

Na dialýze sa však pitný režim rieši veľmi konkrétne, pretože priamo súvisí s prírastkami medzi dialýzami a s tým, koľko tekutiny dialýza odstráni. Dialyzačné edukačné materiály preto prírastky a pitný režim pripomínajú ako praktickú súčasť úspešnosti dialyzačného liečenia [6,7]. Zároveň je dobré vedieť, že peritoneálna dialýza má iný spôsob odstránenia tekutín a iné režimové princípy (nie vždy rovnaké obmedzenia tekutín ako pri hemodialýze), takže presné odporúčania sa vždy majú riadiť vašou metódou a pokynmi tímu [6].



Predialýza vs. Dialýza: Prečo sa pravidlá líšia?



1 Predialýza (Predialyzačné obdobie)

Cieľ: Spomaliť progresiu, zachovať stabilitu.

Tekutinový režim: Menej striktný. Upravuje sa podľa príznakov, tlaku a labákov.

SPOMALENIE



2 Hemodialýza

Cieľ: Stabilita počas liečby.

Pitný režim: Veľmi konkrétny. Priamo súvisí s prírastkami medzi dialýzami.

Dôležitosť: Kľúčový pre komfort a bezpečnosť dialýzy.



3 Peritoneálna dialýza (PD)

Cieľ: Odstránenie tekutín inak.

Pitný režim: Iné režimové princípy. Nie vždy rovnaké obmedzenia tekutín ako pri hemodialýze.



4 Kľúčové posolstvo

Pravidlá sa líšia podľa vášho stavu a metódy liečby.

Vždy sa riaďte pokynmi vášho tímu!





Starostlivosť, spolupráca a informovanosť sú základom lepšej kvality života.



Každodenný život: ako sa režim „nezlomí“ pri cestovaní, chorobe alebo horšej chuti do jedla

Jedna z najväčších výziev pri dialýze a pokročilom CKD je, že život nie je laboratórium. Prídu dni, keď budete mať menej chuti, príde chrípka, hnačka, zvracanie, horúčka alebo cestovanie.

Pri diabetikovi je navyše kľúčové, že zmena príjmu jedla môže zmeniť glykémiu veľmi rýchlo. A pri obličkách môže zmena hydratácie zmeniť tlak a minerály.

Aj preto mnohé edukácie zdôrazňujú, že pacient má vedieť, čo urobiť, keď sa zhorší stav – komu zavolať a aký je „smer“ riešenia (najmä pri opakovaných problémoch alebo dehydratácii/prehnanom smäde). NKF napríklad vo svojich dialyzačných edukáciách smeruje k tomu, aby pacient pracoval so systémom a sledoval, nie aby čakal až na veľký problém [5]. Slovenské dialyzačné príručky obdobne vedú pacienta k tomu, že pravidlá sú na udržanie bezpečnosti a komfortu [6].

Prakticky to znamená: ak máte „zlý deň“ (menej jedla, viac smädu, zmena stolice), nespoliehajte sa len na intuitívne rozhodnutia. Radšej to vopred preberte s tímom alebo aspoň zavolajte, keď sa to opakuje.

Každodenný život s CKD a dialýzou:

— Ako zvládnuť výzvy? —



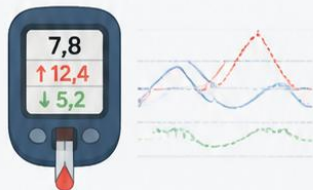
1 Život nie je laboratórium: Neočakávané situácie



Prídu dni, keď budete mať menej chuti, chrípka, hnačka, zvracanie, horúčka alebo cestovanie.

2 Ako sa mení organizmus?

Glykémia (u diabetikov)



Zmena príjmu jedla môže zmeniť glykémiu veľmi rýchlo.

Hydratácia a minerály



Zmena hydratácie mení tlak a minerály.

3 Čo robiť v krízových situáciách?



Komu zavolať?
Aký je smer riešenia?



Prečo neimprovizovať?
Plán je kľúčový.

4 Kľúčové posolstvo: Spolupráca a prevencia

Nespoliehajte sa len na intuitívne rozhodnutia.
Radšej to vopred preberte s tímom alebo aspoň zavolajte.



Vaša bezpečnosť a komfort sú na prvom mieste vďaka spolupráci s tímom.



Kedy je čas kontaktovať tím skôr (a nie až „kým to prejde“)

V dialýze aj v pokročilom CKD platí jedna jednoduchá myšlienka: čím skôr zachytíte odchýlku, tým jednoduchšie sa často dá riešiť. Samozrejme, presný zoznam príznakov má byť podľa vášho centra, ale typicky ide o situácie ako dýchavičnosť, rýchle opuchy, výrazné zmeny prírastkov, opakované závraty alebo ťažkosti počas dialýzy, výrazné zmeny glykémie a príznaky hypoglykémie.

Dialyzačné príručky pre pacientov túto logiku komunikácie „nečakať“ opakovane vysvetľujú v edukácii o režime a bezpečnosti [6]. NKF pri tekutinách a dialyzačných obmedzeniach podobne zdôrazňuje, že tekutinové odporúčania nie sú teoretické, pretože preťaženie tekutinami mení priebeh dialýzy [5].

Kedy kontaktovať tím skôr (a nie až „kým to prejde“)

1



Čím skôr zachytíte odchýlku, tým jednoduchšie sa dá riešiť.



Jednoduché riešenie, rýchlo.

2

Kontaktujte tím, ak sa u vás objaví:



Dýchavičnosť



Rýchle opuchy



Výrazné zmeny prírastkov



Opakované závraty / ťažkosti počas dialýzy



Výrazné zmeny glykémie / príznaky hypoglykémie

3

Preťaženie tekutinami mení priebeh dialýzy.
Tekutinové odporúčania nie sú teoretické.



4

Nečakajte!
Vaša bezpečnosť a komfort sú prioritou.
Komunikujte s tímom.





Bezpečnosť



Komfort



Sme tu pre vás

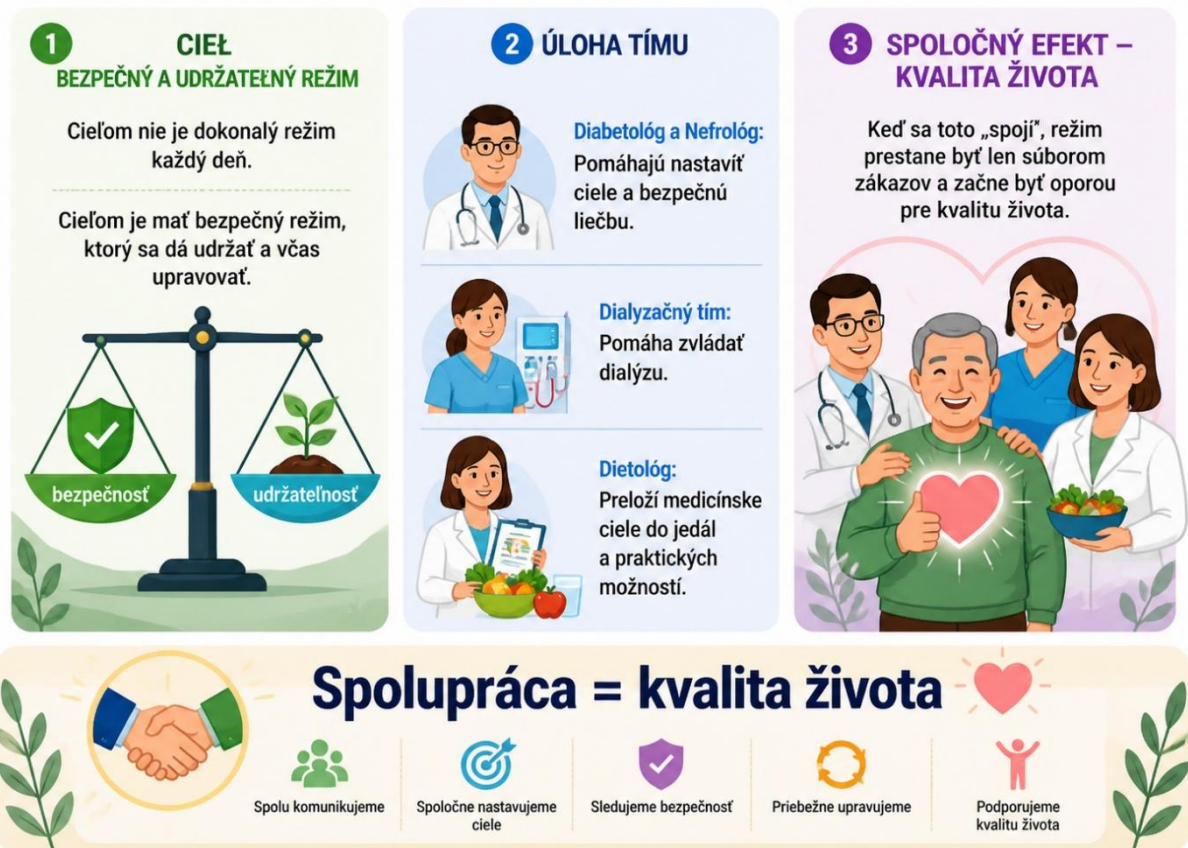
Záver: čo je naozaj cieľom (a aby ste sa cítili menej ako „pacient s pravidlami“)

Keď to celé zhrniem do jedného „ľudského“ odseku, cieľom nie je mať dokonalý režim každý deň. Cieľom je mať **bezpečný režim, ktorý sa dá udržať** a včas upravovať podľa výsledkov a podľa toho, ako na to reagujete vy.

Diabetológ a nefrológ vám pomáhajú nastaviť si ciele a zabezpečiť bezpečnú liečbu. Dialyzačný tím vám pomáha zvládať dialýzu. Dietológ vám preloží medicínske ciele do

jedál a do toho, čo je pre vás prakticky možné. Keď sa toto „spojí“, režim prestane byť len súborom zákazov a začne byť oporou pre kvalitu života.

Záver: Cieľom je bezpečnosť a kvalita života



Autor je nefrológ a internista s rozsiahlymi skúsenosťami v dialyzačnej liečbe, klinickej a preventívnej nefrológii aj v riadení dialyzačných stredísk.

ZDROJE

1. KDIGO 2022 – Diabetes management in CKD (PDF): <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/10/KDIGO-2022-Clinical-Practice-Guideline-for-Diabetes-Management-in-CKD.pdf>
2. KDIGO 2024 – CKD guideline (Executive summary, PDF): <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2017/02/KDIGO-2024-CKD-Guideline-Executive-Summary.pdf> (ďalšia verzia celého dokumentu): <https://kdigo.org/wp-content/uploads/2024/03/KDIGO-2024-CKD-Guideline.pdf>
3. KDOQI 2020 – Nutrition in CKD (fulltext): [https://www.ajkd.org/article/S0272-6386\(20\)30726-5/fulltext](https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(20)30726-5/fulltext)

4. National Kidney Foundation (NKF) – Learning to follow dialysis fluid restrictions:
<https://www.kidney.org/news-stories/learning-to-follow-your-dialysis-fluid-restrictions>
5. National Kidney Foundation (NKF) – Dos and don'ts of fluid management for kidney disease: <https://www.kidney.org/news-stories/dos-and-don-ts-fluid-management-kidney-disease>
6. Dialyza.hello.sk – Príručka pacienta liečeného hemodialýzou (PDF):
<http://dialyza.hello.sk/hemodialyza.pdf>
7. Obličková diéta – Sprievodca výživou pri chronickom ochorení obličiek (SK, PDF):
<https://www.oblickovadieta.sk/wp-content/uploads/2023/12/pruvodce-vyzivou-pri-chronickem-onemocneni-ledvin-sk.pdf>
8. Zväz diabetikov Slovenska (ZDS) – DiaSpektrum (PDF archív, príklady čísel):
9. https://zds.sk/casopis/Diaspektrum_2_2025.pdf
10. https://zds.sk/casopis/Diaspektrum_1_2024.pdf
11. Solen (SK) – Prevencia alebo spomalenie progresie diabetickej nefropatie (PDF):
<https://www.solen.sk/storage/file/article/3a76f564dd0042d82883e6e84da06f1c.pdf>
12. Taiar, R., Cunha, T., & Rodrigues Lacerda, A. (2026). The prognostic value of gait speed in hemodialysis patients: A prospective observational study. PLoS One, 21(3), e0343612.
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0343612>

